Disciplina: PEDIATRIA

Área do conhecimento:
Refluxo gastroesofágico

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta videoaula:
RGE

SUPREMA

Refluxo Gastro Esofágico

OBJETIVOS

1) Diferenciar Refluxo Gastroesofágico fisiológico e Doença do Refluxo (DRGE)
2) Utilizar os métodos diagnósticos para DRGE de forma adequada
3) Realizar o acompanhamento e tratamento do paciente

SUPREMA

Original Article

DOI: 10.1590/0103-0582201432218713

Pediatrician's knowledge on the management of the infant who cries excessively in the first months of life

Conhecimentos do pediatra sobre o manejo do lactente que chora excessivamente nos primeiros meses de vida

Actitud, práctica y conocimiento del pediatra sobre el lactante que llora excesivamente durante los primeros meses de vida

Ana Carolina C. Marcon[1], Mário César Vieira[1], Mauro Batista de Morais[2]

ABSTRACT

Objective: To evaluate the attitude, the practice and the knowledge of pediatricians regarding the management of the infant who cries excessively in the first months of life.

Methods: Descriptive cross-sectional study that enrolled pediatricians (n=132) randomly interviewed at a Pediatric meeting in Brazil, in August 2012. The data were collected by a self-administered standardized form after reading the hypothetical case of an infant who cried excessively.

Results: The majority of the participants were females, the mean age was 39 years and the average mean time working in the specialty was 14 years; 52.2% were Board Certified by the Brazilian Society of Pediatrics. The diagnosis most often considered was gastroesophageal reflux disease (62.9%), followed by infant colic (23.5%) and cow's milk allergy (6.8%). The diagnostic test most frequently mentioned was 24-hour esophageal pH-monitoring (21.9%). The medications most frequently indicated were domperidone (30.3%), the combination of domperidone with ranitidine (12.1%) and paracetamol (6%).

Conclusions: In the approach of the infant who cries excessively, diagnostic tests are frequently requested and unnecessary medical treatment is usually recommended.

Key-words: crying; infant; health education.

RESUMO

Objetivo: Avaliar a atitude, a prática e o conhecimento de pediatras sobre o manejo do lactente que chora excessivamente nos primeiros meses de vida.

Métodos: Estudo transversal descritivo, do qual participaram pediatras (n=132), entrevistados aleatoriamente em evento destinado a especialidade em agosto de 2012. Coletaram-se os dados em uma ficha padronizada e autoadministrada após a leitura do caso hipotético de um lactente que chorava excessivamente.

Resultados: Observou-se maior proporção de pediatras do sexo feminino, média de idade de 39 anos e tempo de formação profissional médio de 14 anos, sendo que 52,2% eram portadores do título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatra. A hipótese diagnóstica mais frequentemente considerada foi doença do refluxo gastroesofágico (62,9%), seguida por cólica do lactente (23,5%) e alergia à proteína do leite de vaca (6,8%). O exame complementar mais frequentemente indicado foi a pH-metria esofagiana de 24 horas (21,9%). As medicações indicadas com maior frequência foram domperidona em 30,3%, combinação de domperidona com ranitidina (12,1%) e paracetamol (6%).

Conclusões: Na abordagem do lactente que chora excessivamente, solicitam-se frequentemente exames complementares e prescrevem-se medicamentos desnecessários.

Palavras-chave: choro; lactente; educação em saúde.

SUPREMA

Introdução

- Muito freqüente
- Consultas a pediatras e gastropediatras
- Fonte de preocupação para família
- Intervenções desnecessárias

SUPREMA

Definições

- Regurgitação: involuntário
- Vômito: expulsão
- RGE: processo normal e fisiológico; autolimitado
- DRGE: associação de complicações esofágicas e extra esofágicas como tosse, broncoespasmo, laringites etc

SUPREMA

Considerações anatômicas

- Esôfago: 2 funções principais:
  - Transporte de alimento
  - Prevenção do retorno (EEI)



SUPREMA

REFLUXO FISIOLÓGICO

X

DRGE

- **LACTENTES**
- **CRIANÇAS MAIORES**
- **GRUPOS DE RISCO como**
  - **Neuropatas,**
  - **Pacientes com cirurgia de Atresia de esôfago,**
  - **Pneumopatias crônicas como Fibrose cística**
  - **Obesidade**

SUPREMA

RGE FISIOLÓGICO "Regurgitador feliz"



- Bom ganho ponderal
- Ausência de complicações
- Raramente antes de 3 semanas e depois de 6 meses

- regurgitações mais evidentes entre 2-4 meses com pico de incidência entre 4-5 meses.

- 4 meses : até 67% dos lactentes regurgitam
- 1 ano : 1% persistem regurgitando

SUPREMA

Doença do Refluxo gastroesofágico (DRGE)

Associação de COMPLICAÇÕES ao RGE (origem esofágica ou extraesofágica)

- Desconforto, choro , irritabilidade, sono agitado
- Desaceleração no ganho ou perda de peso
- Halitose, erosões dentárias
- Dor epigástrica, azia
- Hematêmese, melena , sangue oculto nas fezes
- Tosse persistente, broncoespasmo, asma
- Rouquidão, odinofagia
- Apnéia, cianose
- Pneumonias de aspiração, sinusites e otites de repetição
- Laringites de repetição,
- ALTES: episódios que ameaçam a vida (do inglês *apparent life-threatening events*).

COMPLICAÇÕES CRÔNICA DA DRGE CRÔNICA :
ESÔFAGO DE BARETT E ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO

SUPREMA

Diagnóstico diferencial em lactentes

- **Alergia a Proteína do Leite de vaca**
- **Cólicas**
- **Malformações congênitas (RN) : estenose hipertrófica de piloro e má rotação intestinal**

SUPREMA

Investigação diagnóstica

História & Exame físico : suficientes na maioria dos casos

A) História Alimentar : Freqüência, Quantidade, Tipo, Mudanças, Posição

B) Exame físico : Curva ponderal

SUPREMA

Sinais que sugerem outro diagnóstico para os vômitos

- Gerais: febre , letargia Irritabilidade/dor excessiva, Falha importante de crescimento/emagrecimento, disúria, início de vômitos após os 6 meses ou que persistem após os 12 meses
- Neurológicos: Fontanela tensa Macro/microcefalia Aumento da circunferência cerebral, Convulsões
- Gastrointestinais : Vômitos persistentes
- com perda de peso, vômitos noturnos, vômitos biliosos, Hematêmese/melena, diarreia crônica, distensão abdominal, sangramento retal

SUPREMA

Exames complementares

O exame IDEAL:

- Ocorrência do RGE
- Complicações
- Relação causal RGE/sintomas
- Avalia terapia
- Exclui outras causas

NÃO HÁ UM EXAME IDEAL

CADA INDICAÇÃO: UM EXAME

SABER DECIDIR O MAIS ADEQUADO

SUPREMA

Recomendações para avaliação diagnóstica de crianças com RGE/DRGE

1) REED (radiografia de esôfago, estômago e duodeno)

- Não tem valor para diagnóstico do RGE,
- Não quantifica episódios de RGE
- Avalia apenas RGE pós prandial
- útil para a avaliação de anormalidades anatômicas

2) CINTILOGRAFIA GASTROESOFÁGICA

- Avalia RGE pós prandial imediato
- Detecta aspiração pulmonar mas teste negativo não descarta

Não indicada na pediatria (utilidade questionada)

SUPREMA

Recomendações para avaliação diagnóstica de crianças com RGE/DRGE

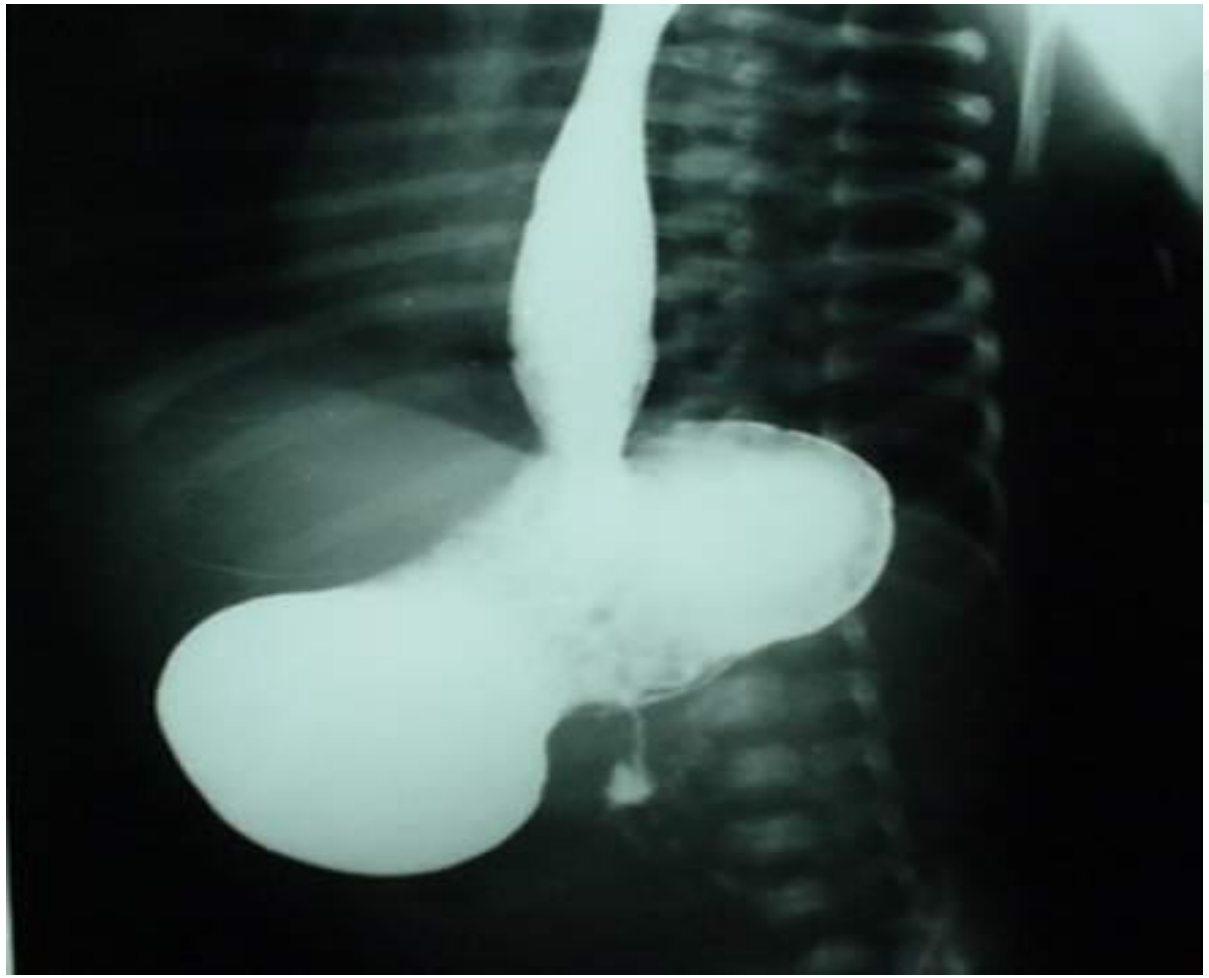
3) ULTRASSONOGRAFIA GASTROESOFÁGICA: importante no diagnóstico de estenose hipertrófica de piloro mas não recomendada para diagnostico de DRGE na pediatria.

4) PHMETRIA ESOFÁGICA DE 24 HORAS : avalia associação episódios de RGE com sintomas

teste útil para diagnóstico do RGE ácido.

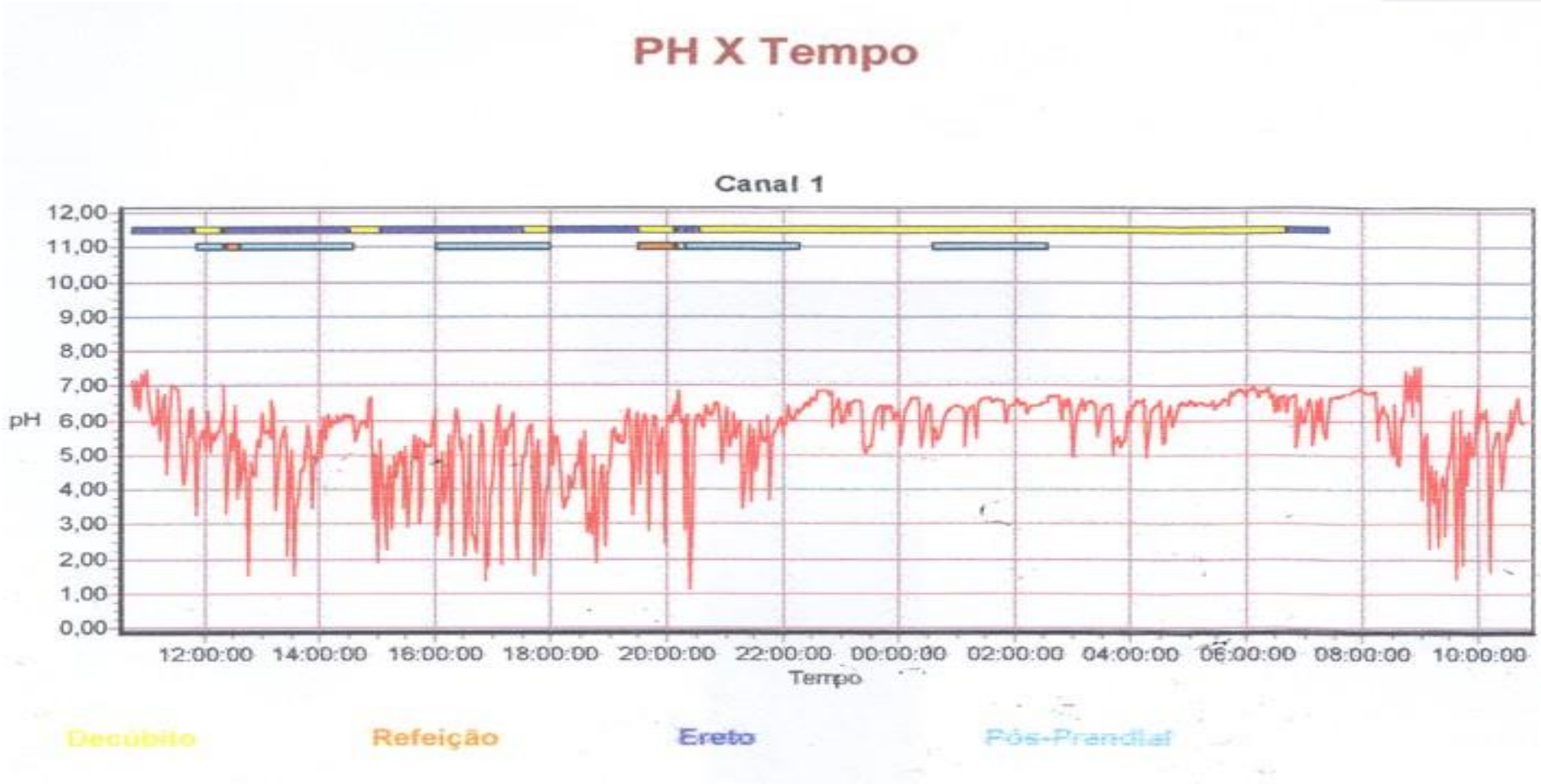
5) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BIÓPSIA :determinam a presença de complicações.

SUPREMA



SUPREMA

PH X Tempo



SUPREMA

Impedanciometria/ pHmetria:

- Melhor avaliação (refluxo ácido ou não)
- Parâmetros para crianças ainda não estão bem estabelecidos.

Manometria esofágica:

- Mede o peristaltismo esofágico
- Útil no diagnóstico de alterações da motilidade que podem se confundir com DRGE.(disfagia)

SUPREMA

Tratamento

- Individualizado
- RGE / DRGE
- Lactente / criança maior
- Objetivos na DRGE:
  - Aliviar sintomas
  - Promover crescimento normal
  - Prevenir ou tratar esofagite
  - Prevenir complicações (respiratórias/esofágicas)

SUPREMA

Etapas

1- Medidas gerais
- Posição
- Alimentação

2- Tratamento medicamentoso
- Procinéticos ???
- Supressores da secreção ácida

3- Tratamento cirúrgico

SUPREMA

Etapas

1- Medidas gerais

a) Posição:

- supina para lactentes
- decúbito lateral esquerdo para crianças maiores, com cabeceira elevada

b) Alimentação:

- espessar fórmulas para lactentes
- evitar *overfeeding*
- teste com hidrolisado proteico por 2-4 semanas (lactentes com vômitos recorrentes) APLV
- redução de peso nos obesos
- Nas crianças maiores : evitar alimentos muito gordurosos (atrasa esvaziamento gástrico), evitar café, refrigerantes , chás e chocolate

c) evitar tabagismo passivo (relaxamento EEI)

SUPREMA

Etapas

2-Medicações

- Discussões e controvérsias
- Utilizar nos casos realmente necessários (RGE patológico)
- Bom senso

SUPREMA

- **Antiácidos e alginatos :** para neutralizar pH ácido – *não há estudos para avaliar real eficácia em pediatria*

- **Citoprotetores (sucralfato):**para proteger mucosa gástrica e esofágica e melhorar sintomas

- **Procinéticos (bromoprida/ domperidona/metoclopramida**): aumentam tônus do EEI e facilitam esvaziamento gástrico; não são indicados de rotina
  - ***Efeitos colaterais SNC > benefícios***

- **Antagonistas receptores H2 de histamina** : inibem a acidez gástrica mas desde 2019 , uso da ranitidina foi suspenso

SUPREMA

❖**Inibidores de bomba de prótons (omeprazol mais utilizado/esomeprazol)**

- Atuam no final da via de secreção ácida
- Superiores aos antagonistas H2
- Uso criterioso devido a efeitos colaterais (hipocloridria; alterações de microbiota intestinal etc)
- Indicações : esofagite erosiva, estenose péptica, esôfago de Barrett ou crianças com RGE + doença respiratória crônica ou sintomas neurológicos
- Teste terapêutico em crianças maiores 4-8 semanas/ Retirada gradual: efeito rebote*

SUPREMA

3- Cirurgia

- Fundoplicatura de Nissen
- Indicações principais
  - Déficits neurológicos
  - Estenoses pépticas
  - Esôfago de Barrett

SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.
- Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Gastroesophageal Reflux: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Publish Ahead of Print.
- Management Guidance for the Pediatrician, Pediatrics; 2013; 131: 1684:1695
- Pediatrician's Knowledge on the Management of the Infant who Cries Excessivelly in the First Months of Life,Rev Paul Pediatr; 2014; 32(2):187-192.
- Gastroesphageal Reflux Disease: Exagerations, Evidence and Clinical Practice,J Pediatr; 2014; 90(2): 105-118

SUPREMA

OBRIGADA !!!

pdahan1@hotmail.com

SUPREMA